

WD8753994C78A
H 371055820FCC

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS J37066739618B

ANDREA TOMEROTTI DOMINGUES

IDADE: 50 PESO: 1,56 ALTURA: 79 PROFISSÃO: Psico pedagoga

SINTOMAS: Dorco; Sonímbulo

QUEIXAS: Deficit memória; sonolência diurna, cansaço, fadiga

MEDICAMENTOS: Micardil, Liprid (furosema) co fraqueza MMII

MÉDICO: Dr. Keffel (cardio) indicou

MARCAPASSO: () S (☒) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: Bicicleta ergométrica - em casa

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 24h HORA QUE ACORDA: 09h

COCHILHO (☒) S () N DORME ACOMPANHADO: (☒) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S (☒) N / DORMEM NO QUARTO: () S (☒) N PET NO QUARTO: () S (☒) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (☒) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (☒) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE: 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IV IAH: 48elh SPO2: 87%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Hipertensão / HAS.

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: no

COMORBIDADE: (☒) RESPIRATÓRIA (☒) ENDÓCRINA (☒) CARDÍACA

(☒) ORTOPÉDICA (☒) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (☒) S () N SPO2 C/ CPAP: 91% PRESSÃO NO EXAME: 5cmH₂O

Fraqueza muscular MMII - cansaço co IAH: 1,9elh

Atalagado - Ruído fixa 5,0 cmH₂O max

comprou Phillips Dream Station

11/11/24 P= 5 cmH₂O fixa Bem adaptada

IAH= 1,9elh

m umd = 8h30 min

fuga = 0

Silvia

29/11/24 P= 5,0 cmH₂O Bem adaptada.

IAH= 1,8elh

m umd = 8h25 min

fuga = 0

Silvia

17/01/25 $P = 5,0 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,2 \text{ e/h}$
m de uso: 8h55'
fuga: $\emptyset$

Bem adaptada

Natacha

17/03/25 $P = 5,0 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,1 \text{ e/h}$
m de uso: 8h38'

Bem adaptada
s/ queixas

Natacha

19/05
25 $P = 5,0 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 2,2 \text{ e/h}$
m. de uso: 9hrs
fuga: 2"

troco o filtro

sua cláudia

Nome: ANDREA TOMEROTTI DOMINGUES

Data de Nascimento: 20-2-1974

IMC: 32,46

Sexo: Feminino

Data do exame: 03-09-2024

Peso: 79 kg

Altura: 1.56 m

Médico: DR. KEFFEL ANTONIO

FERNANDES PEREIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 03-09-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 435,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 96,0 e 152,0 minutos. O tempo total de sono foi de 274,0 min, eficiência de 62,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,6%; estágio N2: 70,4%; estágio N3: 6,0%; sono REM: 21,0%. O índice de despertares foi de 24,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 48,0/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 215 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 87%, permanecendo 2,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 57 - 77 bpm e NREM de 55 - 81 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 48,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=87%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

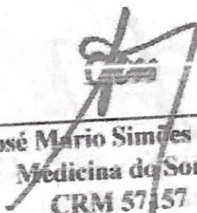
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: ANDREA TOMEROTTI DOMINGUES
Data de Nascimento: 20-2-1974
IMC: 32,46
Sexo: Feminino
Data do exame: 01-10-2024

Peso: 79 kg
Altura: 1,56 m
Médico: DR. KEFFEL ANTONIO
FERNANDES PEREIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 01-10-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO₂) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 449,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 36,0 e 111,5 minutos. O tempo total de sono foi de 342,0 min, eficiência de 76,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 53,7%; estágio N3: 21,9%; sono REM: 22,2%. O índice de despertares foi de 4,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 1,9/hora, sendo 1 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 10 hipopnéias. A SpO₂ média foi de 93% e a mínima de 91%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 47 - 79 bpm e NREM de 46 - 76 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (2), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono aumentada;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (14,2/hora);
6. presença de atividade em EMG de queixo;
7. registro de ronco durante o sono.

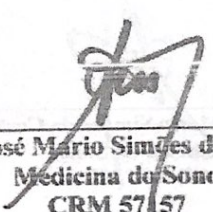
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5 cmH₂O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57